核心精讲

急性阑尾炎

性感认识：转移性右下腹痛

一、可能可能最可能

外科　肠梗阻&阑尾炎1
01:26:43--01:47:55

1.常见病因：青年人淋巴滤泡明显增生等→阑尾阻塞+细菌感染

「理顺知识点」

- 阑尾是免疫器官，内含丰富淋巴组织。30岁后淋巴组织自然退化，青年人因为淋巴滤泡明显增生，易发生阑尾阻塞导致阑尾炎

2.临床表现

①突发转移性右下腹痛（内脏神经定位不准确）：先上腹痛、逐渐移向脐部、约6-8小时后转移并局限于McBurney点（脐与右髂前上棘连线的中外1/3交界处）

注意：转移性右下腹痛还可见于消化性溃疡急性穿孔：突发上腹刀割样剧痛、疼痛可迅速转移至右下腹、肝浊音界缩小消失，X线膈下新月形游离气体

②右下腹固定压痛：诊断急性阑尾炎最早、最常见、最有价值的体征

③发热、血WBC↑

④并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿：肝大、剑突下压痛、可有黄疸，B超→穿刺

「理顺知识点」

- 病原体可经阑尾静脉逆行播散，通过肠系膜上静脉进入门静脉，引起化脓性门静脉炎，进而导致细菌性肝脓肿
  - 肝脏肿大、肝区疼痛（剑突下压痛）、有肝细胞性黄疸等表现→并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿；先用B超定位，必要时在B超的引导下穿刺置管引流

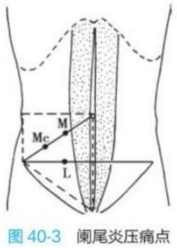
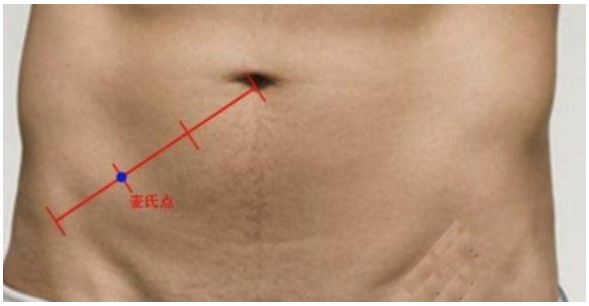


图 40-3　阑尾炎压痛点
M，Morris点；Mc，McBurney点；L，Lenz点；点线围成的四边形为 Rapp 压痛区。

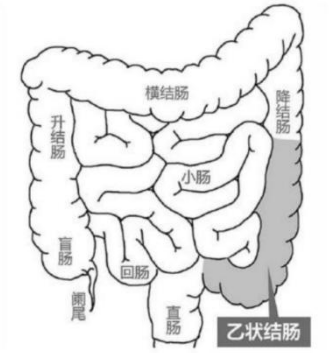


3.试验（pro）

①结肠充气试验Rovsing征 sing：提示阑尾炎，但阴性也不能排除诊断

②腰大肌试验Psoas征（患者左侧卧位）：提示阑尾位置深（盲肠后位/腹膜后位）PS做神猴。盲肠后位/腹膜后位的阑尾炎可有右侧腰背部痛

③闭孔内肌试验Obturator征（患者仰卧位）：提示阑尾位置低（盆位）闭b-仰-低。盆位的阑尾炎其腹痛在耻骨上区、直肠指检直肠前方有触痛











4.影像学（不是必须的）

①超声（首选影像学）：阑尾肿大等

②X线：可见液气平

「理顺知识点」

- 液气平形成的原因：梗阻、腹泻

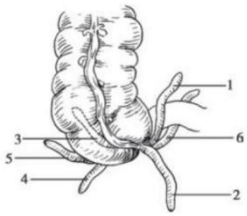


图 40-1　阑尾的解剖位置

1. 回肠前位　2. 盆位　3. 盲肠后位　4. 盲肠下位
5. 盲肠外侧位　6. 回肠后位

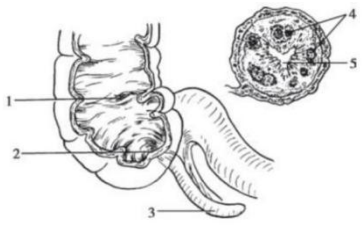


图 40-2　阑尾的解剖

1. 回盲瓣　2. 阑尾开口　3. 阑尾　4. 淋巴组织
5. 阑尾腔



二、发展和治疗

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:00:40--00:13:28



（一）单纯性（早期）

①症状轻、无肌紧张

②切阑尾（麦氏点切口），不冲腹腔、不放引流

（二）化脓性（蜂窝织炎）



Fig. 48.1 Sudden perforation, especially if engendered by purgation, often results in an immediate, widespread bacterial peritonitis.

①局限性腹膜炎（局部压痛/反跳痛/肌紧张），阑尾腔内积脓

②脓液少→纱布沾干渗液后切阑尾（麦氏点切口），不冲腹腔、不放引流

③脓液多→生理盐水冲腹腔后切阑尾（麦氏点切口），根据情况放引流

「理顺知识点」

- 引流管作为异物可增加腹腔感染几率，尤其脓液多时，粘稠的脓液更易粘连；

（三）坏疽穿孔性（阑尾动脉是终末动脉）

①阑尾呈暗紫色，腹痛可暂时减轻、但随即弥漫性腹膜炎（全腹压痛/反跳痛/肌紧张），体温进一步升高、肠鸣音↓、甚至休克

②生理盐水冲腹腔后切阑尾（右下腹经腹直肌切口），根据情况放引流

「理顺知识点」

- 坏疽穿孔性阑尾炎切口采用右下腹经腹直肌切口，以便术中进一步探查和清除脓液

（四）腹盆腔脓肿



1.阑尾周围脓肿

①右下腹包块：波动感、压痛、边界不清、活动度差

②可致瘘管形成→及时放引流：三代头孢+甲硝唑、穿刺/置管引流，若脓肿扩大行手术切开引流

③3个月后切阑尾

「理顺知识点」

- 阑尾周围脓肿本质是大网膜包裹阑尾并形成脓肿，类似消化性溃疡急性穿孔时，胃肠内容物被大网膜 包裹形成上腹包块
- 肠道感染多为G^-杆菌和厌氧菌，因此使用三代头孢+甲硝唑
- 阑尾周围脓肿形成后，阑尾被大网膜包裹，无法直接行阑尾切除术，因此行手术切开引流以控制感染，待 3 个月炎症消退后再切阑尾

2.盆腔脓肿

①肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和/或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）

②首选直肠指检：直肠前壁有触痛的波动性肿块

③直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢+甲硝唑

3.膈下脓肿（负压）

①上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎

②首选B超

「理顺知识点」

- 阑尾炎也可引起膈下脓肿，因为肝脏周围为负压，可吸引液体气体聚集

三、手术并发症「感染猪猪粪血」

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:13:28--00:17:15

①切口感染：最常见，应拆除缝线、通畅引流

②腹腔内出血：多在术后1天内（你搞的），血容量降低、轻度腹膜炎，腹腔穿刺抽出不凝血

③粘连性肠梗阻：痛、吐、胀、停。粘连性肠梗阻难以预防，其发生与纤维素的分解速度有关，与体位、引流等无关

④阑尾残株炎：阑尾残端＞1cm所致，需再次手术

⑤粪瘘

「串联」

- 胃大部切除术术后早期并发症-出血：
  - 1 天内→术中止血不确切（你搞的）
  - 1 周内→吻合口粘膜坏死脱落
  - 1 月内→吻合口感染腐蚀血管

四、特殊类型阑尾炎（老幼病孕）

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:13:28--00:26:42

体征不典型、病情重、发展快，须尽早手术

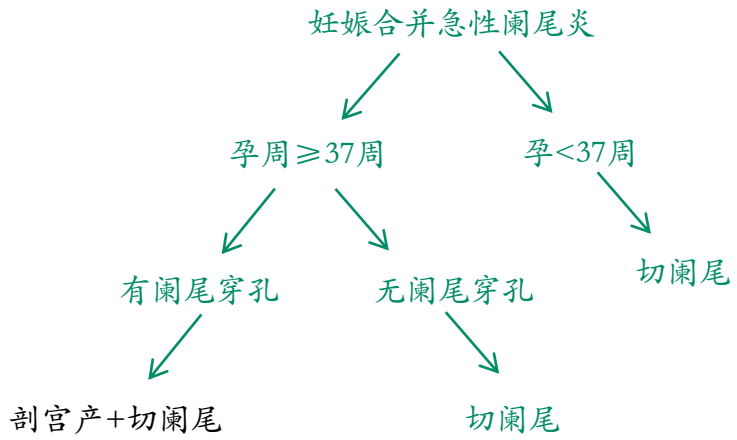
①老年人：感觉迟钝，腹痛等症状不明显（很能忍）

②新生儿：最易穿孔，腹痛等症状不明显（只会哭）

③小儿：腹痛等症状明显

④HIV感染者：WBC多不高

⑤妊娠：手术切口偏高，需加黄体酮，不放引流减少刺激子宫。临产期（37周左右）可剖宫产+切阑尾



小结：一旦确诊急性阑尾炎应早期手术切阑尾，但阑尾周围脓肿除外——其及时放引流、3个月后切阑尾

急性阑尾炎	切口	生理盐水冲腹腔	放引流	围术期抗生素
单纯性	麦氏点	不	不	用
化脓性	麦氏点	脓液少→不 脓液多→要	脓液少→不 脓液多→看情况	用
坏疽穿孔性	右下腹经腹直肌	要	看情况	用
妊娠期	偏高	看情况	不	用

真题解析·阑尾炎

外科　阑尾炎2&大肠癌
00:26:42--00:37:40

1.2013N145-146B

A.中药治疗

B.抗生素治疗

C.保守治疗，无效再行手术

D.尽早手术

6岁儿童患急性阑尾炎，治疗应选择

妊娠36周孕妇诊断为急性化脓性阑尾炎，治疗应选择

2.2014N91-92A女性，22岁。无诱因突发右下腹部剧烈疼痛，向腰骶及会阴部放射，伴头晕、恶心、出大汗、欲排大便感，未作任何处理来院急诊。

91.在询问病史中，对明确腹痛病因价值最大的是

A.转移性腹痛史

B.泌尿系结石史

C.婚姻月经史

D.不洁饮食史

92.该患者体检中不可能出现的体征是

A.肠鸣音亢进　从外面抑制肠子，肠鸣音↓/消失

B.腹部移动性浊音阳性

C.血压下降、心率增快

D.右下腹压痛、反跳痛

3.2014N175X慢性阑尾炎钡灌肠X线的表现有

A.阑尾充盈不全

B.阑尾不充盈

C.阑尾腔不规则

D.阑尾排空延迟至3天以上

4.2015N81A诊断急性阑尾炎，最有意义的体征是

A.右下腹固定压痛

B.腰大肌试验阳性

C.结肠充气试验阳性

D.闭孔内肌试验阳性

　　答案：1-4 DD CA ABCD A

5.2016N178X应尽早手术的阑尾炎包括

A.儿童急性阑尾炎

B.老年人急性阑尾炎

C.妊娠35周急性阑尾炎

D.右下腹可触到包块的阑尾炎

6.2020N60A青少年易发生急性阑尾炎的原因中，最重要的是

A.阑尾发育尚不健全

B.粪石阻塞阑尾管腔

C.寄生虫造成阑尾梗阻

D.阑尾淋巴滤泡组织增生致阑尾梗阻

7.2022N161X下列关于老年人急性阑尾炎的描述，正确的有

A.体征不典型

B.腹痛程度较轻

C.临床症状轻但病理改变重

D.尽量采取保守治疗

8.2023N161X急性阑尾炎可能出现的阳性体征有

A.Rovsing征

B.Cullen征

C.Psoas征

D.Obturator征

9.2025N93-95A女性，45岁。2天前自觉“胃痛”，后感觉右下腹疼痛并逐渐加重，伴恶心呕吐，1天来发热。查体：T38.8℃,P100次/分，R18次/分，BP90/60mmHg。下腹部明显压痛，右下腹肌紧张，肠鸣音1次/分。化验：血WBC19 × 10^9/L，腹部超声示右下腹肠间积液，液深2.0cm。

93.最可能的诊断是

A.卵巢囊肿蒂扭转

B.上消化道穿孔

C.急性机械性肠梗阻

D.穿孔性阑尾炎

　答案：5-9 ABC D ABC ACD DDC

94.拟手术探查，适宜选择的切口是

A.上腹正中切口

B.右侧肋缘下切口

C.下腹正中切口

D.右下腹经腹直肌切口

95.术后第3天体温恢复正常。术后第6天体温再度升高，伴腹痛及里急后重。查体：T38.5℃,下腹部压痛，肠鸣音3次/分。化验：血WBC15 × 10^9/L，Hb120g/L。最可能的诊断是

A.腹腔出血

B.伤口感染

C.盆腔脓肿

D.肠梗阻